

Introducción a la Fibrilación Auricular (FA)

La **Fibrilación Auricular (FA)** es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica. Su manejo es un tema de alta rentabilidad para el examen EUNACOM, ya que requiere una toma de decisiones rápida basada en la estabilidad del paciente y el tiempo de evolución de la arritmia.

- Clínicamente, la FA se clasifica de forma general en dos grandes grupos para definir su manejo inicial:
- FA de reciente diagnóstico (o aguda):** Aquella que se presenta con un inicio claro o detectada recientemente.
- FA crónica:** Aquella que persiste en el tiempo o donde no se busca activamente la reversión a ritmo sinusal de forma inmediata sin preparación previa.

Evaluación Inicial: Estabilidad Hemodinámica

Ante cualquier paciente con sospecha de FA (pulso irregular, palpitaciones, hallazgo en ECG), lo primero y más importante es evaluar la **estabilidad hemodinámica**.

El Paciente Inestable

Se considera que un paciente con FA está inestable si presenta: - Signos de **shock** o hipoperfusión. - **Edema pulmonar agudo (Insuficiencia Cardíaca aguda)**. - Angina inestable o isquemia miocárdica persistente. - Compromiso de conciencia secundario a la arritmia.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si el paciente presenta **inestabilidad hemodinámica**, la conducta siempre es la **Cardioversión Eléctrica (CVE) inmediata**, independientemente del tiempo de evolución de la FA o del riesgo de embolia. En este escenario, el riesgo vital por falla circulatoria supera el riesgo de un evento embólico.

Manejo de la FA de Reciente Comienzo (Estable)

Cuando el paciente está estable, el manejo es farmacológico y sigue una secuencia lógica de tres pilares fundamentales:

1. Control de la Frecuencia Cardíaca (FC)

Es la primera medida. Si el paciente tiene una respuesta ventricular rápida, se debe frenar el nodo AV para mejorar el llenado diastólico y prevenir la falla cardíaca. - **Fármacos habituales:** Se utilizan por vía endovenosa en el escenario agudo. - **Betabloqueadores:** Como el Propranolol o Metoprolol. - **Calcioantagonistas no dihidropiridínicos:** Verapamilo o Diltiazem. - **Digitales:** Digoxina (especialmente si hay insuficiencia cardíaca asociada).

2. Anticoagulación

En la FA aguda o de reciente diagnóstico, la gran mayoría de los pacientes deben ser anticoagulados de inmediato (habitualmente con Heparina en el entorno hospitalario) para prevenir la formación de trombos en la orejuela izquierda durante la arritmia o tras la cardioversión.

3. Cardioversión (Restauración del Ritmo Sinusal)

El objetivo es que el corazón vuelva a su ritmo normal (sinusal). - **Cardioversión Farmacológica:** Se intenta primero con fármacos como Amiodarona, Flecainida o Propafenona. - **Cardioversión Eléctrica Electiva:** Si los fármacos fallan, se puede programar una CVE bajo sedación.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La regla de las 48 horas: - Si la FA lleva **menos de 48 horas**, se puede intentar la cardioversión inmediata (previa anticoagulación). - Si lleva **más de 48 horas** o el tiempo es desconocido, **NO** se debe cardiovertir de inmediato por el alto riesgo de embolia, a menos que se realice un ecocardiograma transesofágico que descarte trombos o se anticoagule por 3-4 semanas antes del procedimiento.

Manejo de la FA Crónica

En la FA crónica, el enfoque cambia de la urgencia a la estrategia a largo plazo. Debemos responder a dos preguntas fundamentales:

¿Control de Ritmo o Control de Frecuencia?

1. **Control de Ritmo:** Intentar mantener al paciente en ritmo sinusal mediante fármacos antiarrítmicos o ablación. Se prefiere en pacientes jóvenes, muy sintomáticos o en su primer episodio. 2. **Control de Frecuencia:** Aceptar la FA como ritmo de base y solo controlar que la frecuencia cardíaca se mantenga en rangos aceptables (habitualmente entre 60 y 90 lpm en reposo). Es la estrategia de elección en pacientes ancianos o con FA de larga data.

¿Anticoagulación Permanente?

A diferencia de la FA aguda, en la crónica no todos se anticoagulan. La decisión se basa en el riesgo embólico calculado mediante el score **CHA2DS2-VASc**.

TABLA 1.8.1: LETRA VS CRITERIO

LETRA	CRITERIO	PUNTOS
C	Insuficiencia Cardíaca (Congestive heart failure)	1
H	Hipertensión Arterial	1
A2	Edad ≥ 75 años (Age)	2
D	Diabetes Mellitus	1
S2	Stroke (ACV), TIA o Embolismo previo	2
V	Enfermedad Vascular (IAM, EVP, Placa aórtica)	1
A	Edad 65-74 años	1
Sc	Sexo femenino (Sex category)	1

NOTA CLÍNICA

El riesgo de embolia es la complicación más temida de la FA. La desorganización de la contracción auricular genera estasis sanguínea, facilitando la formación de trombos, principalmente en la orejuela izquierda.

Identificación de la Causa y Pronóstico

La FA suele ser secundaria a otra patología. Identificar y tratar la causa desencadenante es vital, ya que esto define el pronóstico del paciente.

- Causas frecuentes:**
 - **Hipertensión arterial esencial** (Causa más común a largo plazo).
 - Valvulopatías (especialmente **Estenosis mitral**).
 - **Infarto agudo al miocardio** o isquemia.
 - Hipertiroidismo.
 - Consumo de alcohol ("Holiday Heart Syndrome").
 - Infecciones sistémicas o Sepsis.
 - Cirugía cardíaca reciente.

Resumen de Diferencias en el Manejo

TABLA 1.8.2: CARACTERÍSTICA VS FA RECIENTE DIAGNÓSTICO (ESTABLE)

CARACTERÍSTICA	FA RECIENTE DIAGNÓSTICO (ESTABLE)	FA CRÓNICA
Vía de fármacos	Preferentemente Endovenosa	Preferentemente Oral
Prioridad 1	Bajar FC y Estabilizar	Decidir Ritmo vs Frecuencia
Anticoagulación	Casi siempre (inicial)	Según Score CHA2DS2-VASc
Objetivo Final	Revertir a ritmo sinusal	Controlar síntomas y prevenir ACV

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda siempre: **Inestabilidad = Electricidad.** No pierdas tiempo con fármacos ni calculando riesgos de embolia si el paciente tiene un edema agudo de pulmón o está hipotenso por la FA.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 75 años hipertenso y diabético consulta por FA persistente diagnosticada hace 6 meses. FC en reposo 95 lpm, asintomático. CHA₂DS₂-VASc = 4."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Los 3 pilares del manejo de FA son: (1) Anticoagulación según CHA₂DS₂-VASc (≥ 2 en hombres, ≥ 3 en mujeres); (2) Control de frecuencia (meta FC < 110 en reposo con Betabloqueadores o Verapamilo/Diltiazem); (3) Evaluar control del ritmo según síntomas.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El CHA₂DS₂-VASc determina la necesidad de anticoagulación en FA
- Si la FA tiene más de 48 horas, se requiere anticoagulación previa o ETE antes de cardiovertir
- El control de frecuencia leniente tiene objetivo de FC menor a 110 lpm en reposo
- El control de ritmo se prefiere en pacientes jóvenes, sintomáticos o con FA de reciente comienzo
- Tras cardioversión exitosa se debe mantener anticoagulación mínimo 4 semanas
- Los betabloqueadores son primera línea para control de frecuencia
- La ablación por catéter es opción en FA refractaria a tratamiento farmacológico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIBRILACIÓN AURICULAR: MANEJO)

PREGUNTA 1

Paciente de 78 años con FA de 72 horas de evolución, hemodinámicamente estable. Se planifica cardioversión eléctrica. ¿Qué conducta es la más adecuada antes de cardiovertir?

- A) Cardiovertir de inmediato sin anticoagulación
- B) Anticoagular 3 semanas y luego cardiovertir
- C) Administrar aspirina y cardiovertir
- D) Realizar ecocardiograma transtorácico y cardiovertir
- E) Solo control de frecuencia, nunca cardiovertir

PREGUNTA 2

Hombre de 58 años, hipertenso y diabético, diagnosticado con FA permanente. CHA₂DS₂-VASc de 3. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a tromboprofilaxis?

- A) Aspirina 100 mg al día
- B) Clopidogrel 75 mg al día
- C) Anticoagulación oral
- D) No requiere tromboprofilaxis
- E) Heparina subcutánea crónica

PREGUNTA 3

Paciente con FA e insuficiencia cardíaca con FEVI de 30%. ¿Cuál fármaco está contraindicado para control de frecuencia?

- A) Metoprolol
- B) Digoxina
- C) Verapamilo
- D) Amiodarona
- E) Carvedilol

RESUMEN: FIBRILACIÓN AURICULAR: MANEJO

El manejo de la fibrilación auricular se basa en tres pilares fundamentales: prevención del tromboembolismo, control de la frecuencia cardíaca y control del ritmo. La decisión terapéutica debe ser individualizada según las características del paciente, la duración de la arritmia y la tolerancia hemodinámica. La prevención tromboembólica se evalúa con el score CHA₂DS₂-VASc. Pacientes con score mayor o igual a 2 en hombres o mayor o igual a 3 en mujeres tienen indicación de anticoagulación. El riesgo hemorrágico se evalúa con HAS-BLED. El control de frecuencia se logra con betabloqueadores, calcioantagonistas no dihidropiridínicos o digoxina, con objetivo de frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto en reposo según la estrategia leniente. El control de ritmo se indica en pacientes sintomáticos a pesar de control de frecuencia adecuado, pacientes jóvenes y en FA de reciente comienzo. La cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica. Si la FA tiene más de 48 horas de evolución o duración desconocida, se requiere anticoagulación por al menos 3 semanas previas o ecocardiograma transesofágico para descartar trombo auricular antes de cardiovertir.